

Παροξυσμική Υπερκοιλιακή Ταχυκαρδία

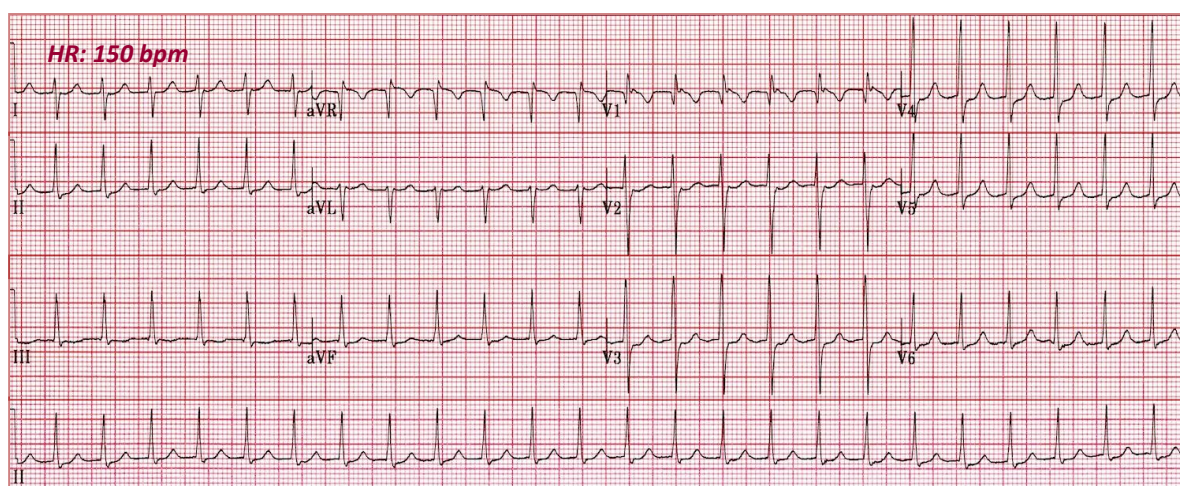
Η Παροξυσμική Υπερκοιλιακή Ταχυκαρδία - Paroxysmal Supraventricular Tachycardia (PSVT), είναι ένας κανονικός, ταχύς καρδιακός ρυθμός, που αρχίζει αιφνιδίως, λόγω επανεισόδου του ερεθίσματος (στο 90% των περιπτώσεων) ή πυροδοτείται από ένα έκτοπο βηματοδοτικό κέντρο το οποίο βρίσκεται πάνω από τη διαίρεση του δεματίου του His και περιγράφεται συχνά ως Atrio-Ventricular Nodal Reentry Tachycardia (AVNRT).

Γενικά, μπορεί να συμβεί σε φυσιολογική καρδιά (ήπια επίδραση αλκοόλ ή καφεΐνης και επί έντονου stress) ή να συνοδεύει χρόνια ρευματική καρδιοπάθεια, οξεία περικαρδίτιδα, OEM, πρόπτωση μιτροειδούς, χολοκυστοπάθεια, πνευμονία ή σύνδρομο προδιέγερσης.

Η έκτοπη υπερκοιλιακή ταχυκαρδία συνήθως εκκινεί από τους κόλπους με κολπικό ρυθμό περίπου 100-250 παλμούς/λεπτό και εμφανίζεται συνήθως σε ασθενείς με OEM, ΧΑΠ, πνευμονία, τοξικότητα από αλκοόλη, κοκαΐνη, διγοξίνη, β-διεγέρτες, αμφεταμίνες.

Κλινική εικόνα: Ο ασθενής παραπονιέται για αίσθημα παλμών, δυσφορία και έντονο άγχος ή μπορεί να εμφανίζει συμπτώματα υποάρδευσης των ιστών, προκάρδιο άλγος, ζάλη, κ.ά.

Διαφορική διάγνωση: Φλεβοκομβική ταχυκαρδία, κολπικές και κομβικές ταχυκαρδίες, κολπική μαρμαρυγή με RVR, κολπικός πτερυγισμός, πολυεστιακή κολπική ταχυκαρδία.



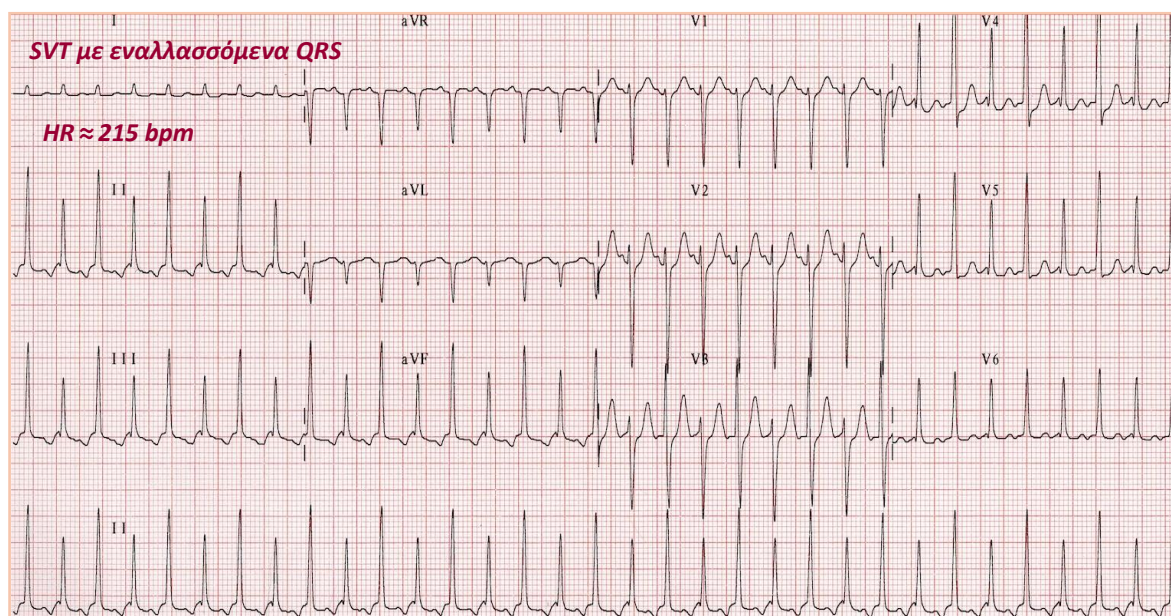
Θεραπευτική παρέμβαση

1. Στους σταθεροποιημένους ασθενείς, χωρίς βεβαρυσμένο ιατρικό ιστορικό, αφού αρχικά τους καθησυχάσουμε, επιχειρούμε χειρισμούς διέγερσης του πνευμονογαστρικού, όπως:
 - ✓ **Μάλαξη καρωτιδικού κόλπου:** Αφού ακροαστούμε προσεκτικά τις καρωτίδες και επιβεβαιώσουμε την απουσία φυσήματος, μαλάσουμε τον καρωτιδικό κόλπο από την πλευρά του μη επικρατούς εγκεφαλικού ημισφαιρίου, για 10-15 δευτερόλεπτα. Ποτέ δεν επιχειρείται η ταυτόχρονη μάλαξη καρωτίδων και στις δύο πλευρές του λαιμού.
 - ✓ **Χειρισμός Valsalva:** Ο ασθενής σε καθιστή ή σε ύπτια θέση προτρέπει να σφίχθει για 10 δευτερόλεπτα ή να φυσήξει σε μία σύριγγα 20 ml προσπαθώντας να ανυψώσει το έμβολο κατά 10-20 ml. Η ταχεία ανύψωση, αμέσως μετά, των κάτω άκρων βοηθά στη φλεβική επιστροφή και μπορεί να αυξήσει την έκλυση του αντανακλαστικού.
 - ✓ **Αντανακλαστικό εμβύθισης:** Εμβυθίζουμε το πρόσωπο του ασθενούς σε μια λεκάνη με ψυχρό νερό ή τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα στο πρόσωπο για 5-10 δευτερόλεπτα. Ο χειρισμός αυτός είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός, ιδίως σε βρέφη και νήπια.
2. Τοποθετείται φλεβική γραμμή και επιχειρούμε φαρμακευτική ανάταξη. Έτσι, χορηγούμε **Αδενοσίνη** (1 amp. Adenocor 6 mg, iv-bolus), ακολουθούμενη από bolus έγχυση 20 ml NaCl 0,9%. Καθησυχάζουμε τον ασθενή, επειδή πιθανώς μετά την έγχυση του φαρμάκου θα νιώσει ένα αιφνίδιο αίσθημα δυσφορίας, δύσπνοια, άλγος παρόμοιο με της στηθάγχης κι έντονη έξαψη ή ζάλη. Τα συμπτώματα παρέρχονται μετά από 1-2 λεπτά ($T_{1/2} \approx 10 \text{ sec}$).

3. Αν η ταχυκαρδία δεν αναταχθεί μετά την πρώτη δόση, επαναλαμβάνουμε τη χορήγηση Αδενοσίνης, μετά από 2 λεπτά, σε διπλάσια δόση, ήτοι 12 mg (δηλαδή 2 amp. Adenocor των 6 mg, iv-bolus). Εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί να χορηγηθεί μετά από 2 λεπτά και μια 3^η δόση Αδενοσίνης 18 mg (δηλ. 3 amp. Adenocor των 6 mg) σε iv-bolus έγχυσης. Η δόση της Αδενοσίνης πρέπει να μειώνεται κατά 50% σε ασθενείς ήδη λαμβάνοντες Βεραπαμίλη (*Isoptin*), Διλτιαζέμη (*Tildiem*), Β-αποκλειστές και Διπυριδαμόλη.

Η Αδενοσίνη ελαττώνει την ταχύτητα αγωγής στον κολποκοιλιακό κόμβο. Η χορήγηση της αντενδείκνυται σε σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου - SSS (εκτός αν συνυπάρχει βηματοδότης), σε υπόταση (όταν ΣΑΠ < 90 mmHg), σε κολποκοιλιακό αποκλεισμό 2^{ου} και 3^{ου} βαθμού και στο βρογχικό άσθμα. Είναι αναποτελεσματική σε κολπικό περυγισμό, κολπική μαρμαρυγή με RVR (που ενίοτε επιβραδύνει ή μπορεί και να πυροδοτήσει) και σε κοιλιακές ταχυαρρυθμίες. Ουσίες, όπως η Διπυριδαμόλη, η Θεοφυλλίνη, η Καφεΐνη ανταγωνίζονται τη δράση της Αδενοσίνης.

4. Στους ασθενείς με ταχυκαρδία με στενά συμπλέγματα QRS και με κανονική καρδιακή λειτουργία, μπορεί να επιχειρηθεί φαρμακευτική ανάταξη με **Βεραπαμίλη** 5-10 mg (δηλαδή με μία σύριγγα των 20 ml αναρροφούμε 2 amp. *Isoptin* των 5 mg / 2 ml μαζί με 10-15 ml NaCl 0,9% και χορηγούμε το διάλυμα βραδέως ενδοφλεβίως εντός 30-90 sec). Για να αποφύγουμε ή να αναστρέψουμε την υπόταση και τη βραδυκαρδία που προκαλεί η Βεραπαμίλη, χορηγούμε 3-5 ml **Χλωριούχο Ασβέστιο 10%** σε διάστημα 5-10 λεπτών. Αν χρειαστεί, η δόση της Βεραπαμίλης επαναλαμβάνεται μετά από 15 λεπτά, μέχρι το όριο των 30 mg. Να αποφεύγεται η χρήση της μετά από β-blockers ή σε δακτυλιδισμό.
5. Σε ασθενείς με διαταραγμένη καρδιακή λειτουργία και ευρέα συμπλέγματα QRS μπορεί να επιχειρηθεί φαρμακευτική ανάταξη με **Αμιωδαρόνη** (εντός 250 ml D₅W διαλύονται 2 amp. *Angoron* 150 mg και χορηγούμε το ήμισυ του διαλύματος εντός 7-10 λεπτών).
6. Στους ασταθείς ασθενείς (με υπόταση, πνευμονικό οίδημα ή στηθάγχη) ή σε ασθενείς με βεβαρυμένο ιστορικό, διενεργείται ηλεκτρική καρδιοανάταξη, αρχικά με ρεύμα περίπου 70-120 J. Αν χρειαστεί, στα επόμενα shock αυξάνουμε την ενέργεια σταδιακά ανά 50 J.
7. Σε περιπτώσεις που ο ασθενής είναι ασταθής, με σοβαρές συννοσηρότητες, προτιμάται η διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο, υπό συνεχές monitoring (*ΗΚΓ*, *ΑΠ*, *RR*, *SpO₂*).



Επί υποτροπιάζουσας, επίμονης, υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας, η οποία οφείλεται σε μηχανισμό επανεισόδου (*AVNRT*), επιχειρείται **ηλεκτρική κατάλυση - καυτηριασμός (ablation)** του υπεύθυνου δεματίου με ειδικό ηλεκτρόδιο - καθετήρα μέσω του οποίου χορηγούνται ραδιοκύματα υψηλής συχνότητας. Η θεραπευτική αυτή επέμβαση είναι δημοφιλής, με επιτυχία μεγαλύτερη του 90%, και πραγματοποιείται με απλό καρδιακό καθετηριασμό κατά τον οποίο με ηλεκτροφυσιολογική μελέτη εντοπίζεται το κύκλωμα επανεισόδου και στη συνέχεια πραγματοποιείται η ηλεκτρική κατάλυση. Οι παρενέργειες είναι γενικώς σπάνιες, π.χ. εμφάνιση διαταραχής της κολποκοιλιακής αγωγής.